

血,多有不同程度的贫血,对于贫血严重者,术前应给予输血、营养支持、对症疗法;对伴有高血压者,应用降压药物控制血压。

3. 术前准备。做好常规检查如血常规、肝肾功能、X 线胸片、心电图、出凝血时间等;双侧腹股沟备皮,术前一晚禁食,床上练习小便,以免术后因不习惯卧床小便而引起排尿困难,必要时留置尿管;备砂袋到介入室。

二、术后护理

1. 穿刺部位处理。穿刺点加压包扎后用砂袋压迫 6~8 h,以防出血,卧床休息 24 h。密切观察穿刺部位有无出血或血肿形成、足背动脉搏动、远端肢体皮肤颜色、温度和感觉有无异常。

2. 生命体征监测。术后 4 h 内测血压、脉搏 1 次/h,血压平稳后改为测血压、脉搏 3 次/d。

3. 注意观察鼻出血情况。嘱病人后鼻孔如有液体流到口腔要吐出,不要咽下,以便观察出血情况,本组病例经栓塞治疗后没有出现再出血。

4. 并发症的观察及护理。(1)脑栓塞。严密监测有无误栓引起的各种症状,如神志、语言、肢体活动、感觉、面部表情肌肉活动、呼吸等情况,如发现异常,立即报告医生。脑栓塞是超选择性血管栓塞术最严重的并发症,多由于栓子反流入颈内动脉系所致;亦可因交通支的开放而发生;操作不当(注入栓子过多过快,压力过大)也可造成^[1];依血管栓塞部位出现相应症状,如偏瘫、失明、面瘫、颅神经损害、昏迷、抽搐、脑水肿,严重者可以死亡。本组病人术后无出现脑栓塞等并发症。(2)头面部疼痛。头面部疼痛是超选择性血管栓塞术后最常见并发症,由于供血动脉血管栓塞或动脉痉挛后局部组织缺血导致组织坏死改变以及异物反应,尤其以用明胶海绵

栓塞更为常见。一般不需特殊处理,可在 3~7 d 症状消失自行恢复,症状明显者可给予止痛剂对症处理。本组 2 例术后出现头面部疼痛,给予适量止痛药物等对症处理后,疼痛缓解。(3)穿刺部位的出血及血肿形成。多由于压迫时间不够或压迫方法不正确,或术后病人穿刺侧肢体活动频繁所致。术后应告知病人正确的体位及注意事项,并用正确方法充分压迫止血。病人术后取仰卧位,穿刺侧下肢伸直,砂袋压在穿刺部位上方,嘱病人穿刺侧下肢 24 h 内尽量少活动。本组病人术后未出现穿刺部位出血及血肿。

三、术后健康教育

术后多饮开水。根据医嘱给予静脉输液,应用抗生素,以加速造影剂的排泄,防止肾功能受损和预防感染;有高血压者,继续治疗原发病;饮食注意营养,避免刺激性食物,多吃水果和蔬菜,保持大便通畅;避免感冒,劳逸结合,适当锻炼。3 个月内避免重体力劳动,有不适随诊。

小 结

严重后鼻出血临床常规处理较棘手。超选择性血管栓塞术可有效治疗严重后鼻出血,但严重并发症仍时有报道^[1]。密切观察及合理有效的术前、术后护理对于提高超选择性血管栓塞术治疗严重后鼻出血成功率和预防并发症的发生具有重要意义。

参 考 文 献

1 林尚泽.严重鼻衄行颌内动脉栓塞术并发脑梗死死亡.中华耳鼻咽喉科杂志,1994,29(4):209-210.

(收稿日期:2004-06-22)

(本文编辑:曲梅)

•实用方法•

一种防止静脉连续滴注药物相互作用的方法

万歆 李绪玲 沙金霞

静脉连续滴注药物的相互作用,是关系临床疗效和用药安全的重要问题。鉴于近代新药不断用于临床和药物相互作用研究相对滞后,特提出一种方法,用于防止这类问题产生,已获得满意效果,现介绍如下。

材料 准备 10 ml 小试管若干支,试管架 1 个,2 种及 2 种以上静脉滴注药物和稀释液各 1 套,特种铅笔 1 只,备用。

方法 在配制静脉滴注药液时,药物注入稀释液摇匀后,随即抽出 2~3 ml 注入试管中,同法抽出第 2 组药液 2~3 ml,注入同一试管,混匀,置试管架上,放暗处 15~30 min

后,取出观察,若未发现变色、混浊或沉淀,即可认定两药无相互作用。若药物超过 2 组,则用同一方法抽取第 3 组药液 2~3 ml 2 份,分别与前 2 组药液混匀,并用特种铅笔标明 1+2,1+3,2+3 后,同法放置后观察。

护理 对未发现相互作用的药液,即可依次用于静脉滴注;已发现有相互作用的药物,应请医师更换品种依法试验,无相互作用再滴注。本法应用后,曾发现庆大霉素与丹参注射液混合产生沉淀 1 例。

(收稿日期:2004-08-03)

(本文编辑:贾艳)